

Pharmasafe OPD การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันความคลาดเคลื่อนในการจัดยา หอกระจายยาผู้ป่วยนอก

Pharmasafe OPD: Development of Surveillance and Prevention System for Pre-dispensing Errors in Outpatient Pharmacy

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ ความคลาดเคลื่อนทางยา(Medication Error) เป็นเหตุการณ์ที่ป้องกันได้ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในขั้นตอน Pre-dispensing ได้แก่ รับใบสั่งยา คัดกรองคำสั่งจ่าย จัดเตรียมยา ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบยาแก่ผู้ป่วย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหรือนำไปสู่การจ่ายยาที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย



ระบบเฝ้าระวังเดิมเน้นการรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขั้นตอนจ่ายยา (Dispensing Error) เป็นหลัก ส่งผลให้ข้อมูลความเสี่ยงในกระบวนการก่อนการจ่ายยา (Pre-dispensing Error) หรือเหตุการณ์เกือบพลาด (Near Miss) ยังไม่ถูกจัดเก็บอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ ซึ่งทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลการบันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนกระบวนการก่อนจ่ายยา พบว่า ระหว่างเดือน ธันวาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนเริ่มโครงการ มีจำนวนใบสั่งยา 40,574 ใบสั่งยา มีการความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนก่อนการจ่ายยาเพียง 221 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.45 ต่อ 1,000 ใบสั่งยา ซึ่งข้อจำกัดในการบันทึกและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกจึงได้พัฒนาระบบการมุ่งเน้นระบบการตรวจสอบซ้ำ (Double Check / เพื่อนช่วยเพื่อน) การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน Real-time และการเรียนรู้ร่วมกัน (Job Training) เพื่อช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดความคลาดเคลื่อนยกระดับความปลอดภัยด้านยา (Medication Safety) สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Patient Safety Culture) ในหน่วยงานและคืนความเชื่อมั่นในการบริการให้แก่องค์กร

Before	After
การจัดเรียงยา เรียงตามตัวอักษร หรือจากการ พิจารณาโดยเภสัชกร อาจเกิดความสับสน หรือความคุ้นชิน	หมุนเวียนตำแหน่งชั้นวาง (Shelf Code) โดยเฉพาะยาที่ พบความคลาดเคลื่อนบ่อยครั้ง ทุกเดือน ป้องกันความผิดพลาด จากความจำ
ยาคู่พ้องมอก คล้าย (LASA) & ยาเสียงสูง (HAD) ป้ายชื่อรูปแบบทั่วไป สังเกตยาก	แยกสีป้ายชื่อชัดเจน เพิ่มสัญลักษณ์หรือลักษณะ บนฉลาก และเปลี่ยนชื่อเรียกให้ต่างกัน เปลี่ยนชื่อเป็น Influenza Vaxigrip ป้องกันสับสนกับ Varivax
การจัดการภาระงาน (Peak Time Load) เจ้าหน้าที่เหนื่อยล้า ใน ช่วงเวลาด่วน (พุธ- พฤหัสบดี)	ปรับกำลังคน พักเป็นเวลา 3 ชั่วโมง (11.00-14.00 น.) ลดความเร่งรีบ (Human Error)

ตัวอย่างความสำเร็จจากการดำเนินงาน

รูปแบบยาที่คล้ายกัน

ยาที่ต้องการ: Risperal syrup

ยาที่หยิบผิด: Keppra solution

ผลลัพธ์ที่ตกใจได้:
ตรวจพบด้วยระบบ
Double Check
และการสื่อสารภาพถ่ายคู่ยา
ผ่าน LINE
ช่วยแจ้งเตือนทีมทันที

ชื่อพ้องคล้าย

ยาที่ต้องการ: Varivax

ยาที่หยิบผิด: Vaxigrip

ผลลัพธ์ที่ตกใจได้:
แก้ไขได้ด้วยเปลี่ยนชื่อ ให้มีความแตกต่าง
และการสื่อสารภาพถ่ายคู่ยา
ผ่าน LINE
ช่วยแจ้งเตือนทีมทันที



บทเรียนที่ได้รับ

การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยา ประกอบด้วยด้วยบทเรียนสำคัญ ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยการรายงานเหตุการณ์เกือบพลาด (Near Miss) เพื่อปรับปรุงระบบจัดยา การใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนแบบ Real-Time เพื่อกระตุ้นความระมัดระวัง และการจัดสิ่งแวดล้อม (Visual Control) เพื่อลดความผิดพลาดจากความคุ้นชิน (Human Error) ส่งผลให้ช่วยลดความเสี่ยงในการจ่ายยาคลาดเคลื่อน เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย และยังเพิ่มโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผ่านการใช้ระบบ Barcode Scanning จับคู่ของยากับชั้นวาง การใช้ระบบไฟนำทางบริเวณชั้นวางยา กลุ่มเสียงสูง (HAD) และยาคู่พ้องมอกคล้าย (LASA) รวมถึงการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับช่วงเวลาหนาแน่น (Peak Time) ซึ่งจะช่วยลดความเร่งรีบและความเหนื่อยล้าของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

